

障害者グループホーム事業

共同生活援助・介護サービス包括型 — 投資家向け事業計画書

定員20名・RC造1棟(全26室) | 日立市(茨城県)

2026年7月

投資ハイライト

茨城県日立市において、障害者グループホーム(共同生活援助・介護サービス包括型)を開設・運営する。
鉄筋コンクリート(RC)造3階建て1棟・全26室。うち居室20室(全室個室)・定員20名で開設し、残る6室は
事務・宿直/仮眠・相談・多目的室に充当(将来の定員拡大に対応)。精神障害・知的障害を主な対象とする。

20名

定員(全室個室・居室20室)

約3.4億円

必要初期費用

487万円

月間売上(満室時)

117万円

月間利益(利益率24.0%)

BEP 75%

損益分岐(15人/20人)

約18年

投資回収期間(満室維持時)

達成率112%

GH需要(供給不足確認)

本提案:必要初期費用 約3.4億円(建設関連 2億4,670万円+運転資金 9,000万円)の資金計画。
調達スキーム(出資・金融機関借入・公的融資の組合せ)は協議の上決定する。

だから何? → 供給不足が実証された市場に、差別化された施設で参入する投資機会

26万人の精神科入院患者

日本には約26万人の精神科入院患者がいる。

その入院費用は1人あたり月額約44万円。年間で約1.4兆円の医療費が投入されている。

この規模の公費負担は、高齢化と精神障害者の増加により今後さらに膨らむ。

約26万人

精神科入院患者数

月44万円

入院1人あたり月額費用

約1.4兆円/年

精神科医療費(推計)

出典:厚生労働省「患者調査」、日本精神科病院協会データ

だから何？ → 公費負担が増え続ける。構造的な解決策が必要

18万人が退院できない

26万人のうち約18万人は「社会的入院」と呼ばれる状態にある。

医学的には退院可能だが、退院後に住む場所がないため入院を継続している。

つまり、住居さえあれば地域で暮らせる人々が病院に留め置かれている。

約18万人

社会的入院(退院可能だが退院先がない)

「住む場所があれば、今すぐ退院できる」——これが18万人の現実

だから何？ → 住む場所があれば今すぐ動ける。GHはその受け皿

入院月44万円 vs GH月18万円

統合失調症の入院費: 1日14,640円 × 30日 = 月額約44万円

グループホームの公費負担: 月額約18万円(障害福祉サービス報酬)

差額: 月26万円 × 12ヶ月 = 年間309万円/人の公費削減

月44万円

入院(精神科病院)



月18万円

GH(地域生活)

1人が退院してGHに移行するだけで、年間309万円の公費が浮く。

だから何? → 1人移行で年309万円の公費削減。20名で年6,200万円

国の「入院から地域へ」政策

- ・ 精神保健福祉法改正(2024):退院支援の義務化・地域移行の促進
- ・ 第7期障害福祉計画:GH整備を数値目標で明記
- ・ 日立市の姿勢:「新規参入の促進」を計画に明記
- ・ 報酬改定:地域移行支援の加算を段階的に引き上げ
- ・ 自治体の責務:退院後の住居確保・支援体制の整備を義務付け

政策の方向性とビジネスの方向性が完全に一致している。

行政が「やってほしい」と言っている事業を行う。

だから何？ → 政策追い風で行政が協力的。逆風になるリスクが低い

グループホームとは

障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害のある方が地域の中で共同生活を営む住居。「介護サービス包括型」は食事・入浴・排泄等の介護を事業所内のスタッフが直接提供する。

提供サービス

- ・ 居住支援:個室(鍵付き)+共用LDK・浴室
- ・ 生活支援:食事提供・服薬管理・金銭管理支援
- ・ 日中活動支援:就労準備・日中活動の送り出し
- ・ 相談支援:生活全般の相談・退院後の地域定着
- ・ 夜間支援:夜勤スタッフ常駐(最大5名/晩)による24時間体制

コンセプト:「ホテルのようにきれいに。施設っぽくしない。自立を目指す家」

だから何? → 利用者に何を提供するかが分かる

日立障害福祉圏 ― 6病院・1,303床

日立障害福祉圏は日立市・高萩市・北茨城市の3市で構成。
圏域内に精神科病院6院・合計1,303床が存在する。全院を営業訪問済み。

市	人口(R5)	障害者数	GH利用者(R5)
日立市	167,501人	12,944人(7.73%)	339人
高萩市	約25,000人	約1,508人	52人
北茨城市	約39,000人	—	60人

日立市の障害者構成比7.73%は県平均4.9%を大幅に上回る

だから何？ → 参入ルートは既に確立されている(全院訪問済み)

需要分析 ー 実績が見込みを常に上回る

日立市のGH需給:実績が見込量を一貫して上回る(平均達成率112%)。
市は「利用希望者も大幅に増加しており、更なるサービス提供体制の整備が必要」と明記。

区分	平成30年度	令和5年度	増減率
身体障害者手帳	5,599	5,894	+5.3%
療育手帳	1,534	1,706	+11.2%
精神障害者手帳	1,136	1,564	+37.7%
精神通院医療	2,613	2,998	+14.7%
合計	11,654	12,944	+11.1%

年度	見込量	実績	達成率
R3	264人	302人	114.4%
R4	286人	320人	111.9%
R5	308人	339人	110.1%
R8見込	454人	—	—

精神障害+37.7%の急増。R8見込454人はR5実績339人比+115人の増加余地。当施設20名はその17%に過ぎない

だから何？ → 空室リスクは構造的に低い。需要が供給を常に上回る

差別化戦略 — なぜRC造 × 夜勤最大5名か

初期費用と夜間人件費を「あえて」厚くする設計。紹介元(病院・相談支援)が最も重視する「夜間の安全」と「受入力」に応えることで、紹介が集まる構造をつくる。

① 耐火・耐震のRC造

夜間火災・災害リスクに構造で対応。スプリンクラー・自火報に耐火構造を重ね、6項口基準を上回る安全水準。法定耐用47年の長期資産。

② 夜勤最大5名/晩

基本3名・支援度に応じ最大5名/晩まで増強できる体制。増強時は夜間支援等体制加算の区分も上がり収支影響は限定的。退院直後・支援度の高い層も受入可能で、病院が安心して紹介できる退院先となる。

③ 全室個室・ホテル品質

鍵付き完全個室26室。家賃3万円/月と障害基礎年金の範囲で入居できる負担設定。「施設っぽくない」住環境で選ばれ、長期入居につながる。

安全と受入力の差別化は、「空室リスクの低減」と「夜間支援等体制加算の確実な算定」として財務に還元される

だから何？ → コスト増は戦略。紹介が集まり、稼働と単価で回収する

支援ネットワーク

この事業は単独で始めるのではない。既に構築済みの支援ネットワークがある。

【医療】圏域6病院を全院営業訪問済み。退院候補者の紹介ルート確立

【相談支援】スペース空・いわき相談支援事業所と連携。入居候補者の直接紹介

【行政】日立市障害福祉課との関係構築。市計画に「新規参入促進」明記

【前計画実績】前計画期間中に6事業所が新規参入。行政の支援実績あり

【地域】日立市は障害者構成比7.73%(県平均4.9%超)で高い社会的関心

だから何？ → 今すぐ動けるチームがある。ゼロからの立ち上げではない

開設スケジュールと認可プロセス

GHの開設には茨城県の指定が必要。日立市が「新規参入の促進」を計画に明記しており、事前相談は実施済み。
2026年内の着工、2028年1月のPhase 1受入開始を目標とする。

時期	マイルストーン
2026年 7～8月	土地確定・実施設計(基本設計と並行して短縮)・日立市事前協議(実施済み)
2026年 9～10月	建築確認申請・消防法6項口対応協議・茨城県への指定事前協議
2026年 11～12月	着工(2026年内・RC造3階建て・工期約11ヶ月)
2027年 10～11月	竣工・消防検査
2027年 12月～2028年 1月	県指定取得・職員採用/研修・内覧会
2028年 1月	Phase 1 受入開始(10名)→ 以後ユニット単位で段階受入

※2026年内着工は土地の早期確定と設計・審査の並行進行が前提。確定時期により1～3ヶ月前後する可能性がある

だから何？ → 開設までの道筋が時系列で明確。不確定要素は少ない

施設計画 — RC造3階建て1棟・全26室

鉄筋コンクリート(RC)造3階建て1棟・全26室。うち居室20室(全室個室)を共同生活住居2ユニット(10名・10名)で構成し、1住居あたり定員10名以下の基準に適合。残る6室は事務・宿直/仮眠・相談・多目的室として活用し、将来の定員変更(最大26名)に対応。延床面積:約700平方メートル。

設備	仕様
居室 20室	各6畳・鍵付き完全個室・ベッド・エアコン
ユニット	2住居(10名/10名・1～2階)・各階にLDK
管理諸室 6室	3階:事務・宿直/仮眠・相談・多目的(将来居室化可)
浴室・トイレ	ユニットバス×各階・洋式温水洗浄便座(各階複数)
構造	RC造・耐火構造(法定耐用年数47年)
面積	延床約700㎡(約35㎡/人)
家賃設定	3万円/月(補足給付対象・年金内で入居可能)

消防設備(6項目)	1棟合計
スプリンクラー(水道連結型)	600万円
自動火災報知設備	200万円
その他+予備費	200万円
消防設備 合計	1,000万円

「ホテルのようにきれいに。施設っぽくしない。自立を目指す家」

だから何？ → 何をどこに建てるか仕様が明確。RC造で夜間の防火安全性も強化

人員体制 — 常勤6名＋パート2名＋夜勤最大5名

介護サービス包括型の人員基準を満たす体制。地域賃金水準に合わせた給与設定で人材確保の差別化を図る。
夜間は基本3名/晩(利用者概ね6～7名につき1名)、支援度に応じて最大5名/晩まで増強できる体制とする。

職種	人数	形態	月給	資格
管理者兼サビ管	1名	常勤	300,000円	実務経験5年
世話人	3名	常勤	200,000円	不要
世話人	1名	パート	100,000円	不要
生活支援員	2名	常勤	210,000円	不要
夜勤スタッフ	基本3名・最大5名/晩(ローテ)	パート	15,000円/回	不要
事務員	1名	パート	100,000円	不要

人件費合計:月額2,870,000円(満室時・月間支出の77.6%) ※夜勤は基本3名/晩×15,000円×30日=1,350,000円

だから何？ → 支援の質が人員体制で担保される。夜間も手厚い配置

月次収支計画(満室時)

収入

区分	月額
基本報酬(区分2+3)	1,521,000円
夜間支援等体制加算 ※	1,500,000円
処遇改善加算等	350,000円
実費(家賃3万+食費3万+光熱水費1.5万)	1,500,000円
月間収入 合計	4,871,000円

損益

項目	金額
月間利益	1,171,000円
年間利益	14,052,000円
利益率	24.0%

支出

区分	月額
人件費(日中:常勤6+パート2)	1,520,000円
夜勤人件費(基本3名/晩×15,000円×30日)	1,350,000円
施設維持費(RC造1棟)	250,000円
運営費	580,000円
月間支出 合計	3,700,000円

実費収入が月間収入の30.8%を占め、報酬改定リスクに対するバッファとなる。
家賃3万円は障害基礎年金の範囲で支払える水準(補足給付1万円の対象)。

※夜間支援等体制加算は夜勤3～5名運用を想定した保守的概算。前提と感度分析は次頁参照

だから何？ → 月収487万・月利益117万。財務の中身が透明

収支の前提条件と感度分析

収支計画の主要前提を明示し、前提が崩れた場合の耐性を検証。最大の変動要因は夜間支援等体制加算と稼働率。

主要前提

項目	前提
基本報酬	障害支援区分2〜3中心・76,050円/人月
夜間支援等体制加算	夜勤3〜5名運用・告示単位の約7割で概算
処遇改善加算等	35万円/月
実費収入	家賃3万+食費3万+光熱水費1.5万=7.5万円/人月
夜勤単価	15,000円/回(地域相場)
稼働	開設後約18ヶ月で満室(段階受入)

感度分析

前提の変動	月間利益への影響	評価
夜間加算 ▲30%	117万 → 72万円	BEP 75%→85%。黒字維持
夜勤5名/晩で常時運用	夜勤費 +90万円/月	加算区分の上昇で概ね相殺
稼働率90%で定常	年間利益 896万円	回収約28年に長期化
建築費 +10%	初期費用 +1,950万円	回収期間 +約1.5年

加算の算定区分は指定申請時に確定するため、確定後に本計画の数値を更新する

だから何？ → 主要前提を開示。単一の前提が崩れても赤字転落しない構造

損益分岐 ー 稼働率75%で黒字

稼働率75%(15人/20人)で損益分岐。夜勤は稼働に応じて2〜3名(支援度により最大5名)で段階配置し、低稼働時の固定費を圧縮する。

稼働率	利用者数	夜勤配置	月間損益
100%	20人	3名	+1,171,000円
90%	18人	3名	+746,900円
80%	16人	3名	+322,800円
75%(BEP)	15人	3名	±0
70%	14人	3名	▲101,300円

投資回収シナリオ

回収対象:建設関連+開業費用 = 2億4,670万円

シナリオ	稼働率	年間利益	回収期間
楽観	100%	1,405万円	約18年
標準	95%(19人)	1,151万円	約21年
保守的	90%(18人)	896万円	約28年

回収期間は事業利益ベース。土地・RC造建物(取得原価ベース約2.3億円・法定耐用47年)の資産価値は別途残存。
建物は26室確保済みのため、需要確認後に定員26名へ変更すれば月利益約144万円・回収約16年に改善(アップサイド)

だから何？ → 満室でなくても成立する。資産と拡大余地が残る投資構造

段階開設モデル — Phase 1 → 2 → 3

建物はRC造1棟のため一括建設とし、受入をユニット(階)単位で段階化する。
人員・夜勤体制を稼働に合わせて立ち上げ、運営リスクを逡減する。

Phase	受入ユニット	累計定員	夜勤配置	月間収入(概算)
Phase 1	1階ユニット(10名)	10人	2名/晩	約261万円
Phase 2	+2階ユニット(10名)	20人	3名/晩	約487万円
将来(オプション)	3階6室を居室化・定員変更申請	26人	最大5名/晩	約623万円

+ 運転資金9,000万円(BEP到達まで2年分)を別途確保
Phase 1で運営実績・入居パイプラインを確認した上で、Phase 2以降の受入を拡大する
※建設投資は一括となるため、圏域6病院との連携による入居予約で稼働立ち上げリスクを抑制する

だから何？ → 受入と人員配置の段階化で運営リスクが逡減する

開設後5年の収支見通し

段階受入を前提とした保守的なランプアップ想定。開設2年目に損益分岐を超え、以降は安定的にキャッシュを創出する。

年次	平均利用者数(稼働率)	夜勤配置	年間損益(概算)
1年目(2028年)	約13人(65%)	2〜3名/晩	▲約380万円
2年目(2029年)	約16人(80%)	3名/晩	+約390万円
3年目(2030年)	約18人(90%)	3名/晩	+約900万円
4年目(2031年)	約19人(95%)	3名/晩	+約1,150万円
5年目(2032年)	19〜20人(95〜100%)	3名/晩	+約1,150〜1,400万円

1年目の資金流出(▲約380万円+開設前の採用・研修費用)は運転資金9,000万円です十分にカバーできる。

3年目以降に定員26名への変更を実行した場合、年間利益は約1,700万円規模への拡大余地。

※月次収支モデル(P15)を利用者数別に展開した概算。入居ペースは圏域6病院との連携による紹介を前提

だから何？ → 2年目に黒字化。運転資金には大幅な余裕がある

年6,200万円の社会的コスト削減

入院からGHへの移行1人あたり: 月26万円 × 12ヶ月 = 年309万円の公費削減

20名満室の場合: 309万円 × 20人 = 年間6,180万円(約6,200万円)の公費削減

年309万円/人

入院→GH移行による公費削減

年6,200万円

20名分の年間公費削減額

投資額3.4億円に対して、毎年6,200万円の社会的リターンを生む。

この事業への出資は、そのまま公費削減に直結する。

だから何? → 出資 = 公費削減。社会的リターンが明確

波及効果 — 経済的リターンを超えた価値

【個人】 病院ではなく「自分の部屋」で暮らす。鍵のかかる個室。自炊もできる。人間の尊厳の回復

【地域】 20名の生活消費が地域経済に還流。日用品・食材・交通・医療の地域内消費

【医療】 病床の回転率向上。急性期治療を必要とする患者への病床再配分が可能に

【財政】 年6,200万円の公費削減。削減された財源を他の福祉施策に転用可能

【雇用】 常勤6名＋パート2名＋夜勤ローテ(最大5名/晩)の地域雇用を創出。福祉人材のキャリアパス提供

だから何？ → 経済的リターンを超えた、多層的な社会的価値を生む

拡張計画 ー 日立から茨城全域へ

第1号は日立市内での展開。成功モデルが確立されれば、日立障害福祉圏の他市(高萩市・北茨城市)、さらに茨城県内他圏域への横展開が可能。

日立市 vs 高萩市 比較評価

評価軸	重み	日立市	高萩市
市場規模	25%	12,944人 ◎	~1,508人 △
GH需要見込	20%	454人 ◎	77人 △
需給ギャップ	20%	供給不足確定 ◎	需要未到達 ○
自治体の姿勢	15%	新規参入促進 ◎	成果目標のみ ○
競合環境	10%	26事業所 ○	少数 ◎
土地コスト	10%	3~8万/坪 △	1.5~4万/坪 ◎
加重スコア	100%	4.30	2.75

第1号は日立市。高萩市は第2号以降の候補

だから何？ → 拡張モデルへの投資。成功すれば横展開できる

リスク管理と対策

想定されるリスクとその対策。すべてのリスクに具体的な緩和策を準備。

リスク	影響度	対策
入居者不足	高	供給不足(達成率112%)+年金内で払える家賃3万円で障壁を低減。段階受入+運転資金2年分
人材確保困難	中	地域賃金水準。仮眠室完備で差別化
建設コスト増	中	RC造は複数社見積・設計VEで抑制。予備費を計上
報酬改定	中	実費収入が月間収入の30.8%。感度分析で耐性確認済み
回収長期化	中	RC造・法定耐用47年の長期資産。定員26名への変更(建物対応済み)で約16年に短縮余地
競合参入	低	+115人の成長余地で20人を吸収。RC造×夜間体制の差別化で優位

だから何？ → 主要リスクへの備えが具体的。想定外を最小化

資金使途 ー 必要初期費用3億3,670万円

本計画は「必要な初期費用の総額」として提示。資金調達の内訳は別途協議。

区分	金額	備考
土地取得(250坪)	2,500万円	坪単価10万円
建築費(1棟・延床約700㎡)	1億9,500万円	RC造3階建て・坪単価約92万円
付帯工事	1,000万円	外構・駐車場
消防設備	1,000万円	6項口対応
家具・備品(居室20室+管理諸室)	400万円	
建設関連 小計	2億4,400万円	
開業費用	270万円	法人設立・車両等
運転資金(2年分)	9,000万円	BEP到達まで
必要初期費用 合計	3億3,670万円	約3.4億円

調達は出資・金融機関借入・公的融資(独立行政法人福祉医療機構等)の組合せを想定し、詳細は協議の上決定。
自治体の施設整備補助の活用可能性も精査する。

だから何？ → お金の使い道が透明。全額の使途が明確

まとめ — だから今、出資する価値がある

社会的意義

18万人の社会的入院。住む場所さえあれば退院できる人々に「家」を提供する

公費削減

20名で年6,200万円の公費削減。出資がそのまま社会的リターンになる

市場の裏付け

GH達成率112%。需要が供給を常に上回る日立市に、データに基づいて参入

安全設計

段階受入。運転資金2年分。感度分析済み。RC造47年の長期資産+26室確保で定員拡大余地

実行体制

圏域6病院全院訪問済み。相談支援事業所との連携確立。行政が参入を促進

次のステップ: ① 詳細財務モデル・算定根拠の開示 ② 土地候補の現地確認 ③ 行政・病院ヒアリングへの同席 ④ 出資条件・スキームの協議

お問い合わせ・詳細資料のご請求はお気軽にご連絡ください